

仲恩生醫法說會整理

定位：臨床、藥證與商業化進度更新

一、主管快速閱讀版

1. 法說會核心結論

- 1. 核心產品 **Stemchymal** 已從研發階段走向藥證申請及商業化準備。
公司將其定位為異體、現貨供應型的細胞藥品，而非醫療院所現場操作的細胞療法。
- 2. 日本是目前進度最明確的市場。
公司表示已於 2026 年 6 月 24 日正式提出日本藥證申請，接下來關鍵是 2026 年第三、四季的 GMP 查核（藥品製造品質查核）。
- 3. 公司目標於**2027**年在台灣及日本取得許可並開始商業化。
但這是公司目標，不是確定結果。日本仍須完成審查、GMP查核及保險藥價協商；台灣的新審查路徑則尚無公司完整走過。
- 4. 台灣及日本臨床試驗均採隨機、雙盲、安慰劑對照設計。
公司認為兩地試驗均看到病程穩定或分數略為改善的趨勢，台灣約1.5分、日本約1分。
- 5. 產品主要價值不是治癒，而是延緩或停止惡化。
對小腦萎縮症患者而言，臨床目標是維持現有行動能力，例如延後從拐杖進展到輪椅、從輪椅進展到臥床。
- 6. 目前主要適應症為**SCA3**及**SCA6**。
台灣及美國以SCA3為主，日本則同時布局SCA3及SCA6。
- 7. 商業模式不只授權，還包含製造收入。
第一階段由台灣生產後冷鏈運送至日本；第二階段規劃把細胞種源及關鍵製程移轉至日本合作夥伴，在當地放大量產。
- 8. 公司規劃治療人數由**2027**年逐步增加，**2030**年挑戰**3,000**人。
由於療程為每年連續三個月、每月施打一劑，因此理論上具有重複性收入，但實際病人滲透率及藥價尚未確定。
- 9. 這次法說會沒有提供完整財務資料。
未揭露營收、現金水位、研發費用、每劑成本、毛利率、授權分潤、資本支出或EPS預估，因此目前無法建立可靠估值。

2. 法說會訊息判斷

面向	判斷	原因
臨床進度	偏正面	台灣、日本已有對照試驗，結果方向具一致性

日本藥證	偏正面	已正式送件，進入GMP查核及審查階段
台灣藥證	中性偏正面	已進入新制輔導路徑，但制度尚無成功案例
美國進度	正面但早期	公司稱二期試驗最快10月開始收案
商業化準備	偏正面	已建立日本MAH、經銷及製造合作架構
藥價與健保	高度不確定	公司只提供其他罕病藥物比較，尚無自身核價
財務可見度	偏弱	缺乏成本、收入、現金及損益預測
整體判斷	中性偏多、高風險	關鍵里程碑接近，但尚未轉化為可估算的營收及EPS

二、公司與產品定位

1. 公司概况

項目	公司說法
成立時間	約19年
股本	上一輪增資完成後約8.06億元
員工人數	約54人
資本市場	目前在興櫃，並準備上市
發展模式	曾接受法人及創投進行技術、財務與團隊盡職調查
海外進度	兩個海外授權、兩項孤兒藥認定、三個國家IND，其中兩個臨床試驗已完成

2. 核心產品

產品名稱：**Stemchymal**

產品特性：

- 異體細胞產品
意即細胞來源不是每位病人自己，而是由合格捐贈來源建立標準化產品。
- 現貨供應型
可以預先製造、儲存及配送，不必為每一位患者重新培養。

- 脂肪來源幹細胞
公司認為脂肪組織較骨髓、臍帶血或牙髓容易取得，較適合商業化放大。
- 採GMP藥品規格製造
具有原料、製程、活性及品質標準。
- 可再現性生產
公司主張不同批次可按照相同標準製造。
- 液態氮保存
公司目前的穩定性資料支持保存三年。

3. 作用機轉

公司表示，Stemchymal可能透過細胞本身的修復及調節作用，抑制異常或受損蛋白質堆積，進而延緩神經退化。

但本次法說會沒有提供：

- 具體作用標的
- 生物標記變化
- 劑量與療效關係
- 作用機轉的完整臨床驗證

因此目前仍應將作用機轉視為支持產品合理性的科學證據，不能直接等同臨床療效。

三、疾病及適應症布局

1. 主要疾病

產品目前聚焦於脊髓小腦性共濟失調症，法說會中簡稱小腦萎縮症。

患者可能出現：

- 走路不穩
- 容易跌倒
- 平衡能力下降
- 說話含糊
- 手部協調惡化
- 最終可能需要輪椅或臥床

目前治療重點不是根治，而是延緩病程惡化及維持生活自理能力。

2. 適應症布局

市場	主要適應症	目標患者
----	-------	------

台灣	SCA3	臨床評分大於或等於9分
日本	SCA3、SCA6	日本SCA6患者比例相對較高
美國	SCA3	規劃進行單藥二期試驗
未來	其他SCA型別及神經退化疾病	須另行完成臨床及法規程序

3. 平台擴張邏輯

公司認為，一旦Stemchymal完成首項適應症取證，未來可以沿用：

- 同一個細胞主庫
- 同一套CMC製造與品質系統
- 同一套生產平台
- 同一個通路
- 同一批合作夥伴

因此後續開發其他適應症的成本，理論上會低於從零開始開發新藥。

研究員判斷：

這項平台價值成立的前提是：

1. 首項適應症成功取證。
2. 不同適應症能使用相近的劑量與製程。
3. 法規機關接受既有CMC資料延伸使用。
4. 新適應症確實呈現療效。

目前仍屬潛在價值，不能提前全部反映為營收。

四、臨床試驗結果

1. 臨床設計優勢

公司已在台灣及日本完成兩項：

- 隨機分組
- 雙盲
- 安慰劑對照
- 多中心或跨院臨床試驗

相較許多沒有安慰劑對照組的細胞治療研究，這是仲恩臨床資料的重要優勢。

2. 台灣臨床試驗

項目	內容
一期試驗	約6名患者，基準評分約10至20分
二期試驗	公司稱約五十多至60名患者完成收案
主要族群	SCA3、臨床分數大於或等於9分
主要目標	與安慰劑相比，延緩或停止疾病惡化
公司說法	治療組多數維持原有分數，部分患者略有改善
公司提出的幅度	約1.5分

公司以影片說明評分變化的實際影響：

- 對照組患者由9分惡化至14分後，站立能力明顯下降。
- 另一名患者由13分惡化至19.5分後，語言能力明顯退化。
- 治療患者原先需要扶牆行走，半年後可在旁人保護下自行行走。
- 部分患者站立時間、手部翻轉及語言表現改善。

3. 日本臨床試驗

項目	內容
試驗中心	約10家醫院、10名主要研究者
適應症	SCA3及SCA6
公司說法	與台灣試驗呈現相同方向
改善幅度	約1分
差異原因	公司認為SCA6自然惡化速度較慢，因此組間差異較小

4. 競品比較

公司表示，曾使用一項進入三期的競爭藥物所採用的分析方法，重新分析Stemchymal數據：

項目	公司引用結果
對照藥物改善幅度	約0.65分

Stemchymal改善幅度	約1至1.5分
公司結論	效果可能優於對照藥物

研究員判斷：

這項比較只能作為參考，不能視為正式頭對頭試驗，原因包括：

- 患者基準條件可能不同
- SCA型別可能不同
- 試驗時間可能不同
- 統計方法及缺失值處理可能不同
- 沒有直接隨機比較

因此「效果為競品一倍」是公司敘事，不能直接當成確定結論。

5. 美國個案與論文

公司表示：

- 一篇病例相關論文已於6月29日接受。
- 個案曾同時使用另一款藥物及Stemchymal。
- 在合併Stemchymal期間，病患評分下降；停止後病程再度惡化。
- 美國小腦萎縮症專家Susan Perlman參與相關研究及顧問工作。

研究員判斷：

個案報告的價值是建立科學關注及國際醫師合作，但只有單一或極少數病例，且存在合併用藥，因此證據強度明顯低於隨機對照試驗。

6. 長期療效

目前正式對照資料最長約60週，公司另外有恩慈療法患者持續施打兩年至三年的觀察資料。

但恩慈資料存在以下限制：

- 沒有安慰劑對照組
- 患者病情可能較嚴重
- 患者及家屬知道接受治療
- 未必能公開或用於正式法規主張

因此長期療效仍是目前最大的臨床缺口之一。

五、藥證與商業化進度

1. 日本

里程碑	公司說法
藥證送件	2026年6月24日正式提出
前期溝通	與PMDA及日本合作夥伴溝通約15個月
近期重點	2026年第三、第四季GMP查核
審查期間	公司引用法規時程為送件後約9個月
取證後	進行保險藥價協商
藥價程序	問答中提到程序可能約6個月
上市目標	2027年

日本商業模式

第一階段：台灣製造

1. 仲恩在台灣生產。
2. 以液態氮冷鏈運送至日本。
3. Reprocell擔任MAH(藥證持有商)。
4. 再由當地經銷通路銷售。

第二階段：日本在地量產

- 將關鍵細胞種源及製程移轉至日本。
- 與Cytori討論在日本放大量產。
- 降低整瓶成品跨境液態氮運輸成本。
- 提高供貨量及供應彈性。

公司在問答中表示，取得日本許可後，Reprocell將準備支付尾款，公司也會開始準備出貨。

2. 台灣

公司表示於2026年7月1日進入台灣再生醫療相關輔導及審查程序。

逐字稿同時出現「TRmed」及「TRMAC」兩種名稱，正式專案名稱應以公司公告或主管機關資料為準。

公司描述的制度重點：

- TFDA、CDE、GMP單位及醫藥專家共同審查。
- 輔導過程約每兩週追蹤。

- 輔導階段形成的意見具有約束力。
- 如果公司完成要求，後續審查程序可能約120天。
- 台灣尚未有公司完整走過此程序。

公司內部準備假設：

- 前期溝通約6個月。
- 後續正式審查約4個月。
- 公司以總計約10個月作為管理準備。

研究員判斷：

台灣路徑雖可能加速，但由於尚無成功案例，不能把10個月直接當成確定取證時程。

3. 美國

公司表示：

- 美國二期臨床試驗已送件。
- 採Stemchymal單藥治療，不是聯合治療。
- 最快可能於2026年10月完成首位患者給藥。
- Susan Perlman可能擔任臨床主持醫師。

目前未揭露：

- 預計收案人數
- 試驗中心數
- 主要及次要終點
- 完成收案時間
- 預計數據公布時間
- 美國後續三期或取證路徑

六、療程與收入模式

1. 給藥方式

公司描述的療程為：

- 每月施打一劑
- 連續施打三個月
- 每年共三劑
- 隔年再重複相同療程

因此理論年收入公式為：

年度產品收入＝治療患者數×每年3劑×每劑淨售價×仲恩可認列比例

但目前缺少四個關鍵數字：

1. 實際每劑價格
2. 健保及保險折扣
3. 日本合作夥伴分潤比例
4. 每劑製造及冷鏈成本

所以現階段不能合理推估毛利或EPS。

七、市場規模與病患人數

1. 公司提供的病患估計

市場／疾病	公司引用數字
台灣小腦萎縮症	約1,000人
日本小腦萎縮症	約5,000多人
協會登記相關患者	約23,000多人
MSA相關患者	約10,000多人
公司2030年治療目標	約3,000人

2. 主要問題

流行病學估計與協會登記數字差距極大，可能涉及：

- 疾病定義不同
- 基因型不同
- 患者與會員口徑不同
- 是否包含未確診或相關疾病
- 是否全部符合臨床評分條件
- 是否全部適用Stemchymal

因此23,000人不能直接視為可治療市場。

真正可治療病人應逐層計算：

1. 確診SCA患者

2. 符合SCA3或SCA6基因型
3. 臨床分數符合核准標籤
4. 身體狀況可接受治療
5. 醫師願意處方
6. 保險或患者能支付
7. 願意每年持續治療

公司提出2030年治療3,000人的目標，但法說會未提供滲透率推導，因此目前只能視為產能準備目標，而非可靠銷售預測。

八、藥價與健保

1. 公司提出的比較案例

公司引用多項罕病及細胞治療藥物價格：

- SMA基因治療一次性價格可達數千萬元至上億元。
- 部分SMA治療每年費用約800多萬元。
- 血友病每年藥費約500萬至700萬元。
- 靜脈注射細胞產品，每劑市場價格可能約9萬至20萬美元。
- Skyclarys每年藥費約37萬美元。
- 日本相關市場在2017年的外部估計約110億日圓。

2. 必須注意的錯誤推論

不能因為其他罕病藥物售價很高，就直接推論Stemchymal也能獲得相同價格。

最終價格取決於：

- 臨床改善幅度
- 效果可以維持多久
- 是否需要終身治療
- 替代治療成本
- 患者生活品質改善
- 住院及照護成本降低程度
- 健保預算影響
- 上市後三期及長期追蹤結果

3. 長期效果與核價

問答中投資人指出，目前正式資料主要只有約一年的效果，若效果只維持一年，與可維持五年的藥物，其經濟價值完全不同。

公司承認：

- 長期效果仍須持續追蹤。
- 保險方未來會重新評估療效持續時間。
- 取得上市許可不代表藥價永久不變。
- 若患者須長期使用，保險方可能要求降價。

研究員判斷：

健保給付不是必然。即使獲得給付，實際價格也可能採：

- 限定患者條件
 - 療效達標續用
 - 分期付款
 - 風險分攤
 - 上市後追蹤
 - 藥價定期檢討
-

九、製造與產業鏈

1. 公司策略

仲恩過去自行涵蓋：

- 細胞來源
- 細胞培養
- 製程開發
- 品質檢測
- 製造
- 包裝
- 冷鏈
- 臨床產品供應

未來公司將集中於：

- 關鍵細胞種源
- 產品規格
- 核心製程
- 品質標準
- IP及法規能力

較大量、標準化的製造環節則交給合作夥伴。

2. 主要合作夥伴

依逐字稿列示：

夥伴	可能角色
Reprocell	日本MAH及上市承接
Cytori	日本及亞洲製造放大合作
Terumo BCT	自動化及細胞製程合作
澀谷相關團隊	製程或設備開發
吉帝、永華	台灣商業或授權合作
日本經銷商	上市後銷售
Susan Perlman等專家	科學及臨床顧問

具體合約範圍、分潤比例、最低採購量及里程碑付款，法說會均未揭露。

十、法說會問答重點

1. 日本取證後多久能上市？

公司表示：

- PMDA審查程序約9個月。
- 取證後還要進行保險藥價協商。
- 藥價程序可能約6個月。
- 取得許可後，Reprocell準備支付尾款並開始出貨準備。

判斷：

藥證與上市之間仍有藥價及供貨準備時間，不能把取得許可日直接當作大量營收起始日。

2. 台灣審查需要多久？

公司以約6個月溝通加120天正式審查作為內部準備。

判斷：

這是管理假設，不是主管機關承諾，而且新制沒有成功先例。

3. 美國二期何時開始？

公司表示最快2026年10月完成首位患者給藥。

判斷：
First patient in只是試驗開始，不代表短期可取得療效數據。

4. 台灣是否能取得健保給付？

公司表示會同時利用再生醫療及罕病資格爭取給付。

判斷：
仍須通過成本效益及預算影響評估，沒有保證。

5. 二期取證是否合理？

公司表示部分罕病及再生醫療產品可以二期資料取得附條件上市，但後續仍須補做三期。

判斷：
附條件上市並非免除三期；三期失敗、延遲或安全性問題，仍可能影響藥證及商業化。

6. 長期療效是否足夠？

公司承認正式對照資料最長約60週，另有恩慈治療患者持續兩年至三年的觀察。

判斷：
這是核價、續用條件及長期銷售的核心風險。

十一、EPS與財務影響

1. 正面項目

項目	潛在影響
日本取證	可能觸發授權尾款、製造及銷售收入
台灣取證	建立本地產品收入及健保談判基礎
美國二期啟動	提高海外授權價值
日本在地量產	降低長期冷鏈及供貨成本
患者重複施打	建立經常性收入

適應症擴張	攤提既有平台及製程成本
-------	-------------

2. 負面項目

項目	潛在影響
審查延遲	營收遞延、資金消耗增加
GMP查核缺失	需補件或整改
健保核價偏低	營收及毛利低於預期
三期試驗支出	研發費用持續上升
製造放大不順	單位成本上升、供貨受限
長期效果不足	續用率及支付意願下降
增資需求	股權稀釋

3. 暫時無法建立EPS預估

法說會缺少：

- 現金及約當現金
- 每年現金消耗
- 研發費用
- 美國二期及上市後三期成本
- 每劑製造成本
- 年產能
- 合作夥伴分潤
- 授權尾款金額
- 藥價假設
- 目標毛利率
- 完全稀釋後股數

因此現階段任何EPS或合理價計算，都會高度依賴主觀假設，可信度很低。

十二、後續股價催化劑

按重要性排序：

1. 日本GMP查核結果
 2. 日本PMDA是否提出重大補件要求
 3. 日本藥證審查結果
 4. 日本保險藥價及給付條件
 5. Reprocell授權尾款金額及認列時間
 6. 台灣新制審查正式進度
 7. 美國二期首位患者給藥
 8. 美國二期試驗設計及收案人數公布
 9. 論文正式刊登
 10. Cytori日本在地製造合作進度
 11. 上市計畫及資金規劃
 12. 長期追蹤數據公布
-

十三、主要風險

1. 藥證時程風險

公司把日本九個月、台灣約十個月作為管理時程，但主管機關可能補件、要求額外試驗或延後查核。

2. 臨床證據風險

目前公司強調約1至1.5分效果，但逐字稿未完整揭露：

- p值
- 信賴區間
- 主要終點是否達標
- 各組患者人數
- 安全性資料
- 缺失值處理
- 統計分析方法

僅憑法說會敘述，不能確認臨床試驗是否達到統計顯著。

3. 療效定位限制

產品核心價值是穩定疾病，而不是治癒或明確逆轉。穩定疾病具有臨床價值，但患者及支付方願意支付的價格，可能低於能明確改善或治癒的療法。

4. 長期持續效果不足

正式對照資料約60週，尚不足以證明多年持續有效。

5. 市場規模高估

公司引用的23,000名患者與流行病學估計差距過大，不能直接當成可治療人數。

6. 藥價及健保不確定

公司大量引用其他罕病藥物價格，但不同疾病、效果、療程及支付能力不能直接比較。

7. 製造放大風險

細胞產品的批次一致性、活性、存活率、冷鏈及跨國技術轉移，都比一般藥品更複雜。

8. 合作夥伴依賴

日本上市涉及MAH、製造商及經銷商。任何一方進度落後，都會影響收入認列。

9. 資金及稀釋風險

公司仍須推進美國二期、上市後三期、GMP查核及商業化，未來可能需要再次募資。

10. 管理層敘事偏樂觀

法說會將取證、藥價、3,000名患者及平台擴張串成完整商業故事，但中間仍缺少多個尚未完成的法規與支付里程碑。

十四、最終投資判斷

法說會定調：中性偏多，但仍是高風險里程碑型生技公司

正面理由

- 台灣及日本均已隨機雙盲安慰劑對照試驗。
- 兩地臨床結果方向一致。
- 日本已進入正式藥證審查。
- 產品具現貨供應及重複給藥特性。
- 日本商業、製造及經銷架構已開始建立。
- 美國二期若啟動，可提高海外授權價值。
- 罕病市場存在較高藥價及政策支持可能。

保留理由

- 尚未確認主要臨床終點是否達統計顯著。
- 長期效果資料不足。
- 日本與台灣取證時程都不是保證。
- 健保給付及藥價高度不確定。
- 3,000名患者目標缺乏滲透率推導。
- 沒有足夠財務數據估算營收、毛利及EPS。
- 未揭露未來三期試驗及商業化所需資金。

核心結論

這場法說會真正的重點不是「幹細胞市場有多大」，而是：

仲恩已從純研發公司，進入日本藥證審查、台灣新制審查及美國二期準備的交叉階段。

但投資上不能把「已送件」等同「必定取證」，也不能把其他罕病藥物的高價直接套用到Stemchymal。

現階段最有價值的觀察指標是：

1. 日本GMP查核是否順利
2. PMDA是否提出重大補件
3. 臨床主要終點及統計資料是否完整公開
4. 日本核准標籤涵蓋哪些患者
5. 實際藥價及仲恩可認列比例
6. 美國二期是否如期啟動
7. 公司現金是否足以支撐至商業化

在上述資訊揭露前，仲恩比較適合視為藥證事件驅動型標的，而不是已經能用本益比衡量的成熟獲利公司。